

RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO

1. NOME DO MEDICAMENTO

BIPARFEN 25 mg/ml + 20 mg/ml suspensão oral

2. COMPOSIÇÃO QUALITATIVA E QUANTITATIVA

Cada ml de suspensão oral contém 25 mg de paracetamol e 20 mg de ibuprofeno.

Cada seringa doseadora (6 ml de suspensão oral) contém 150 mg de paracetamol e 120 mg de ibuprofeno.

Excipiente(s) com efeito conhecido:

Sódio – 1,93 mg/ml

Benzoato de sódio – 2 mg/ml

Isomalte – 70 mg/ml

Lista completa de excipientes, ver secção 6.1.

3. FORMA FARMACÊUTICA

Suspensão oral

Suspensão esbranquiçada com sabor a laranja

4. INFORMAÇÕES CLÍNICAS

4.1 Indicações terapêuticas

BIPARFEN é indicado em crianças, a partir dos 2 anos, no tratamento sintomático de curta duração de febre, dor ligeira a moderada e/ou inflamação, associadas a sintomas de gripes e constipações, dor de garganta, dor de cabeça, dor de dentes, dor muscular, dor nas costas, dor menstrual e enxaqueca.

Este medicamento é especialmente indicado para a dor que requer um efeito analgésico mais forte do que o paracetamol ou o ibuprofeno em monoterapia.

4.2 Posologia e modo de administração

Posologia

Os efeitos indesejáveis poderão ser minimizados utilizando a dose eficaz mais baixa durante o período de tempo mais curto necessário para controlar os sintomas (ver secção 4.4).

Em adultos, a dose máxima diária não deve exceder 3000 mg para o paracetamol e 1200 mg para o ibuprofeno. Nas crianças, o paracetamol e o ibuprofeno são doseados de acordo com o peso corporal. A dose máxima diária para o paracetamol é de 60 mg/kg, até 2000 mg. A dose máxima diária para o ibuprofeno é de 30 mg/kg, até 1200 mg.

A embalagem inclui uma seringa para uso oral graduada em ml e em kg, correspondendo ao volume de suspensão oral e ao peso corporal da criança, respetivamente:

Cada graduação de 1 kg equivale a 0,5 ml de suspensão oral (contendo 12,5 mg de paracetamol e 10 mg de ibuprofeno)

A suspensão oral deve ser administrada de acordo com o peso corporal da criança, marcado na seringa. Por exemplo, para uma criança de 10 kg, encher a seringa até à graduação 10 kg. No caso de adultos e crianças com mais de 12 anos, considerar sempre um peso corporal de 40 kg.

O intervalo entre as doses deve ser de, pelo menos, 6 horas. Não administrar mais de 3 doses em 24 horas.

Compromisso renal

Não é necessária qualquer redução da dose em doentes com compromisso ligeiro a moderado da função renal (doentes com insuficiência renal grave, ver secção 4.3).

Compromisso hepático (ver secção 5.2)

Não é necessária qualquer redução da dose em doentes com compromisso ligeiro a moderado da função hepática (doentes com disfunção hepática grave, ver secção 4.3).

População pediátrica

BIPARFEN não é recomendado para crianças com idade inferior a 2 anos, dado que não existem dados suficientes para suportar a sua utilização neste grupo etário.

Modo de administração

A embalagem inclui uma seringa de 6 ml (graduada até 12 kg de peso corporal).

Apenas para administração oral e destinado a tratamentos de curta duração (não mais de 3 dias). Se for necessário administrar este medicamento mais de 3 dias, ou se os sintomas se agravarem, deve-se consultar o médico.

Antes de cada utilização, o frasco deverá ser vigorosamente agitado.

A suspensão oral pode ser tomada durante ou fora das refeições. Recomenda-se que os doentes com suscetibilidade gástrica tomem BIPARFEN após as refeições.

4.3 Contraindicações

O uso deste medicamento é contraindicado:

- em doentes com hipersensibilidade conhecida ao paracetamol, ao ibuprofeno, a outros anti-inflamatórios não esteroides (AINE) ou a qualquer um dos excipientes mencionados na secção 6.1.
- em uso concomitante com outros produtos que contenham paracetamol - risco aumentado de efeitos adversos graves (ver secção 4.5).
- em uso concomitante com outros produtos que contenham AINE, incluindo inibidores específicos da ciclooxygenase-2 (COX-2) e doses de ácido acetilsalicílico superiores a 75 mg por dia - aumento do risco de reações adversas (ver secção 4.5).
- em doentes que tenham apresentado asma, urticária ou reações do tipo alérgico após tomar ácido acetilsalicílico ou outro AINE.
- em doentes com história de hemorragia ou perfuração gastrointestinal, relacionada com terapêutica anterior com AINE.
- em doentes com ulceração/hemorragia péptica ativa ou história de ulceração/hemorragia péptica recorrente (dois ou mais episódios distintos de ulceração ou hemorragia demonstrada).
- em doentes com insuficiência hepática grave ou insuficiência renal grave (ver secção 4.4).
- em doentes com insuficiência cardíaca grave (classe IV da NYHA).
- em doentes com hemorragia cerebrovascular ou outra hemorragia ativa.
- em doentes com perturbações na formação do sangue.
- durante o terceiro trimestre de gravidez (ver secção 4.6).

- em crianças com menos de 2 anos de idade.

4.4 Advertências e precauções especiais de utilização

Os efeitos indesejáveis poderão ser minimizados utilizando a dose eficaz mais baixa durante o período de tempo mais curto necessário para controlar os sintomas. Este medicamento destina-se a um uso de curta duração e não se recomenda a sua utilização durante mais de 3 dias.

Compromisso hepático

O uso de paracetamol em doses acima das recomendadas pode levar a hepatotoxicidade e até mesmo a insuficiência hepática e morte. Adicionalmente, os doentes com função hepática comprometida, ou com história de doença hepática, que estejam a receber tratamento com paracetamol ou terapêutica de ibuprofeno a longo prazo, devem ser monitorizados quanto à função hepática em intervalos regulares, uma vez que tem sido reportado um efeito pequeno e transitório do ibuprofeno nas enzimas hepáticas. Recomenda-se a redução da dose em doentes com sinais de agravamento da função hepática. O tratamento deve ser interrompido nos doentes que desenvolvam insuficiência hepática grave (ver secção 4.3).

Foram reportados casos de reações hepáticas graves, incluindo icterícia e hepatite fatal, embora raros, com ibuprofeno tal como com outros AINE. Caso persistam ou se agravem os testes hepáticos anormais, caso se desenvolvam sinais e sintomas clínicos consistentes com doença hepática ou caso ocorram manifestações sistémicas (p. ex. eosinofilia, erupção cutânea, etc.), o ibuprofeno deve ser descontinuado. Tem sido reportado que ambas as substâncias ativas causam hepatotoxicidade e até mesmo insuficiência hepática, em particular o paracetamol.

Os doentes que consumirem regularmente mais álcool do que as quantidades recomendadas não devem tomar este medicamento.

Compromisso renal

O paracetamol pode ser usado em doentes com doença renal crónica sem ajustes posológicos. Existe um risco mínimo de toxicidade do paracetamol em doentes com insuficiência renal moderada a grave. No entanto, para o componente ibuprofeno deste medicamento, recomenda-se precaução ao iniciar o tratamento com ibuprofeno em doentes com desidratação. Os dois principais metabolitos do ibuprofeno são excretados principalmente na urina e poderá ocorrer compromisso da função renal com a acumulação dos mesmos. O significado deste facto é desconhecido. Reportou-se que os AINE causam várias formas de nefrotoxicidade: nefrite intersticial, síndrome nefrótica e insuficiência renal. O compromisso renal resultante do uso de ibuprofeno é normalmente reversível. Em doentes com compromisso renal, cardíaco ou hepático, em doentes que tomam diuréticos e inibidores da ECA e nos idosos, recomenda-se precaução uma vez que o uso de fármacos anti-inflamatórios não esteroides poderá resultar na deterioração da função renal. Nestes doentes, a dose deve ser mantida o mais baixa possível e a função renal deve ser monitorizada. O tratamento deve ser interrompido nos doentes que desenvolvam insuficiência renal grave (ver secção 4.3).

Uso combinado de inibidores da ECA ou antagonistas dos recetores da angiotensina, fármacos anti-inflamatórios e diuréticos tiazídicos

O uso combinado de um fármaco inibidor da ECA (inibidor da ECA ou antagonista dos recetores da angiotensina), um fármaco anti-inflamatório (AINE ou inibidor da COX-2) e um diurético tiazídico, aumenta o risco de compromisso renal. Isto inclui o uso de medicamentos de combinação fixa que contêm mais de uma classe de fármacos. O uso combinado destes medicamentos deve ser acompanhado por um aumento da monitorização da creatinina sérica, particularmente no início da combinação. A combinação de fármacos destas três classes deve ser usada com precaução particularmente nos doentes idosos ou doentes com compromisso renal preexistente.

Idosos

Não é necessário nenhum ajuste na posologia indicada para doentes idosos que precisem de terapêutica com paracetamol. Os doentes que precisem de terapêutica durante mais de 10 dias devem consultar o seu médico para monitorização da condição; no entanto, não é necessária nenhuma redução na posologia recomendada. Contudo, recomenda-se precaução relativamente ao uso de ibuprofeno, uma vez que não pode ser tomado por adultos com mais de 65 anos de idade sem consideração das comorbilidades e medicação concomitante devido a um aumento do risco de efeitos adversos, em particular insuficiência cardíaca, ulceração gastrointestinal e compromisso renal.

Efeitos hematológicos

Foram reportados casos raros de discrasias sanguíneas. Os doentes a receber terapêutica de longa duração com ibuprofeno devem ter monitorização hematológica regular.

Perturbações da coagulação

Tal como outros AINE, o ibuprofeno pode inibir a agregação plaquetária. Demonstrou-se que o ibuprofeno prolonga o tempo de sangramento (mas dentro do intervalo normal), em indivíduos normais. Devido ao facto de este efeito de sangramento prolongado poder ser exagerado em doentes com perturbações hemostáticas subjacentes, os medicamentos que contêm ibuprofeno devem ser usados com cuidado em pessoas com perturbações da coagulação intrínsecas e em pessoas a receber terapêutica anticoagulante.

Acontecimentos gastrointestinais

Hemorragia, ulceração e perfuração gastrointestinal (GI): foram reportados casos de hemorragia, ulceração ou perfuração GI, que podem ser fatais, com todos os AINE em qualquer momento durante o tratamento, com ou sem sintomas de aviso ou história prévia de acontecimentos GI graves.

O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração GI é mais elevado com doses crescentes de AINE, em doentes com história de úlcera, particularmente se complicada com hemorragia ou perfuração (ver secção 4.3), e em idosos. Estes doentes devem iniciar o tratamento com a dose mais baixa disponível.

O risco de hemorragia, ulceração ou perfuração GI é mais elevado com doses crescentes de AINE, em doentes com história de úlcera, particularmente se complicada com hemorragia ou perfuração (ver secção 4.3), e em idosos. Estes doentes devem iniciar o tratamento com a dose mais baixa disponível.

A terapêutica de combinação com agentes protetores (p. ex. misoprostol ou inibidores da bomba de prótons) deve ser considerada para estes doentes, bem como para doentes que precisem concomitantemente de uma dose baixa de ácido acetilsalicílico ou outros medicamentos propensos a aumentar o risco gastrointestinal (ver abaixo e secção 4.5). Os doentes com história de toxicidade GI, particularmente os idosos, devem comunicar qualquer sintoma abdominal não habitual (especialmente hemorragia GI), em particular nas etapas iniciais do tratamento.

Recomenda-se precaução em doentes a receber medicação concomitante que possa aumentar o risco de ulceração ou hemorragia, tal como corticosteroides orais, anticoagulantes como a varfarina, inibidores seletivos da recaptção da serotonina ou agentes antiplaquetários tais como o ácido acetilsalicílico (ver secção 4.5).

Devido ao componente ibuprofeno, este medicamento deve ser administrado com precaução em doentes com história de doença GI (colite ulcerosa, doença de Crohn), bem como em doentes com porfiria e varicela.

Este medicamento deve ser descontinuado se houver qualquer indício de hemorragia ou ulceração gastrointestinal.

O uso de BIPARFEN concomitantemente com AINE, incluindo inibidores seletivos da COX-2, deve ser evitado.

Idosos: Os idosos apresentam um aumento da frequência de reações adversas a AINE, especialmente hemorragia e perfuração gastrointestinal que podem ser fatais (ver secção 4.2).

Acontecimentos trombóticos cardiovasculares

Estudos clínicos sugerem que o uso de ibuprofeno, particularmente numa dose elevada (2400 mg/dia), poderá estar associado a um pequeno aumento do risco de acontecimentos trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou AVC). No geral, estudos epidemiológicos não sugerem que

ibuprofeno a doses inferiores (p. ex. ≤ 1200 mg/dia) esteja associado a um risco aumentado de acontecimentos trombóticos arteriais.

Os doentes com hipertensão não controlada, insuficiência cardíaca congestiva (classes II–III da NYHA), doença cardíaca isquêmica estabelecida, doença arterial periférica e/ou doença cerebrovascular devem apenas ser tratados com ibuprofeno após consideração ponderada, devendo ser evitadas as doses elevadas (2400 mg/dia).

Deve-se igualmente realizar uma consideração ponderada antes de iniciar tratamento a longo prazo em doentes com fatores de risco para acontecimentos cardiovasculares (p. ex. hipertensão, hiperlipidemia, diabetes mellitus, tabagismo), particularmente se forem necessárias doses elevadas de ibuprofeno (2400 mg/dia).

Hipertensão

Os AINE podem levar a um aparecimento de nova hipertensão ou ao agravamento da hipertensão preexistente, podendo os doentes a tomar medicamentos anti-hipertensores com AINE, ter uma resposta anti-hipertensora comprometida. Recomenda-se precaução ao prescrever AINE a doentes com hipertensão. A pressão arterial deve ser monitorizada atentamente durante a iniciação do tratamento com AINE e posteriormente em intervalos regulares.

Insuficiência cardíaca

Observou-se retenção de fluidos e edema em alguns doentes a tomar AINE; portanto, recomenda-se precaução em doentes com retenção de fluidos ou insuficiência cardíaca.

Reações cutâneas graves

Os AINE podem em casos muito raros causar acontecimentos adversos cutâneos graves, tais como dermatite exfoliativa, necrólise epidérmica tóxica (NET) e síndrome de Stevens-Johnson (SST), o que pode ser fatal e ocorrer sem aviso. Aparentemente, os doentes apresentam um risco mais elevado de desenvolver estas reações no início da terapêutica: o aparecimento da reação ocorreu, na maior parte dos casos, no primeiro mês de tratamento. Os doentes devem ser aconselhados sobre os sinais e sintomas de reações cutâneas graves e a consultar o seu médico ao primeiro aparecimento de erupção cutânea ou qualquer outro sinal de hipersensibilidade.

Asma preexistente

Os medicamentos que contêm ibuprofeno não devem ser administrados em doentes com asma sensível ao ácido acetilsalicílico e devem ser usados com precaução em doentes com asma preexistente.

Efeitos oftalmológicos

Observaram-se efeitos oftalmológicos adversos com AINE; em conformidade, os doentes que desenvolverem distúrbios visuais durante o tratamento com produtos que contêm ibuprofeno devem ser submetidos a um exame oftalmológico.

Meningite assética

Foram reportados apenas raramente casos de meningite assética para medicamentos contendo ibuprofeno, normalmente mas nem sempre em doentes com lúpus eritematoso sistémico (LES) ou outras perturbações do tecido conjuntivo.

Potenciais interferências com testes laboratoriais

Usando sistemas analíticos atuais, o paracetamol não causa interferências com ensaios laboratoriais. No entanto, há certos métodos com os quais existe a possibilidade de interferências laboratoriais, conforme descrito abaixo:

Testes de urina:

O paracetamol, em doses terapêuticas, pode interferir com a determinação do ácido 5-hidroxi-indolacético (5HIAA), causando resultados falsos positivos. As falsas determinações podem ser eliminadas evitando a ingestão de paracetamol algumas horas antes e durante a recolha da amostra de urina.

Mascarar sinais de infeção

Os AINE podem mascarar sintomas de infeção e febre.

Com o uso prolongado de analgésicos, podem ocorrer dores de cabeça que não podem ser tratadas aumentando a dose do medicamento.

População pediátrica

Este medicamento não é recomendado para crianças com idade inferior a 2 anos.

Precauções especiais

Para evitar exacerbação da doença ou insuficiência adrenal, os doentes que tenham estado a receber terapêutica prolongada com corticosteroides devem ser submetidos a um desmame lento da respetiva terapêutica, em vez de esta ser descontinuada abruptamente quando são adicionados ao programa de tratamento produtos que contêm ibuprofeno.

Há alguns indícios de que os fármacos que inibem a síntese da ciclo-oxigenase ou de prostaglandinas podem afetar a fertilidade feminina através de um efeito na ovulação. Isto é reversível após interromper o medicamento.

BIPARFEN contém isomalte (E953). Doentes com problemas hereditários raros de intolerância à frutose não devem tomar este medicamento.

BIPARFEN contém 2 mg de benzoato de sódio por cada ml de suspensão. O benzoato de sódio pode aumentar a icterícia em bebés recém-nascidos (até 4 semanas de idade).

BIPARFEN contém menos do que 1mmol (23 mg) de sódio por cada ml de suspensão, ou seja, é praticamente “isento de sódio”.

4.5 Interações medicamentosas e outras formas de interação

Este medicamento (como qualquer outro que contenha paracetamol) é contraindicado em combinação com outros produtos que contêm paracetamol - risco aumentado de efeitos adversos graves (consulte a Seção 4.3).

Foram detetadas as seguintes interações de paracetamol com outros medicamentos:

- Fármacos anticoagulantes (varfarina) — pode ser necessária uma redução da dose caso se tome paracetamol e anticoagulantes durante um período de tempo prolongado.
- A absorção de paracetamol é aumentada por substâncias que incrementam o esvaziamento gástrico, p. ex. a metoclopramida e a domperidona.
- A absorção de paracetamol é reduzida por substâncias que diminuem o esvaziamento gástrico, p. ex. propantelina, antidepressivos com propriedades anticolinérgicas e analgésicos narcóticos.
- O paracetamol pode aumentar as concentrações plasmáticas de cloranfenicol.
- O risco de toxicidade do paracetamol pode estar aumentado em doentes a receber outros fármacos potencialmente hepatotóxicos ou fármacos que induzem enzimas microssomais hepáticas como o álcool e agentes anticonvulsivantes.
- A administração de probenecida pode afetar a excreção e as concentrações plasmáticas de paracetamol.

- A colestiramina reduz a absorção de paracetamol se administrada no período de 1 hora após o paracetamol. Foram reportados casos de hepatotoxicidade grave em doses terapêuticas ou sobredosagens moderadas de paracetamol em doentes a receber isoniazida em monoterapia ou combinada com outros fármacos para o tratamento da tuberculose.
- Ocorreu hepatotoxicidade grave após o uso de paracetamol num doente a tomar zidovudina e cotrimoxazol.

Este medicamento (como qualquer outro que contenha ibuprofeno/ outros AINE) é contraindicado em combinação com:

- Ácido acetilsalicílico: de um modo geral, a administração concomitante de ibuprofeno e ácido acetilsalicílico não é recomendada devido ao potencial aumento de efeitos adversos, a menos que o ácido acetilsalicílico em baixas doses (não superior a 75 mg) tenha sido recomendado por um médico (ver secção 4.4). Dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir competitivamente o efeito de doses baixas de ácido acetilsalicílico sobre a agregação plaquetária quando administrados de modo concomitante. Apesar de haver incertezas no que se refere à extrapolação destes dados para a situação clínica, não pode ser excluída a possibilidade de que o uso regular e a longo prazo de ibuprofeno, pode reduzir o efeito cardioprotetor de baixas doses de ácido acetilsalicílico. Não se considera provável nenhum efeito clinicamente relevante decorrente do uso ocasional de ibuprofeno (ver secção 5.1).
- Outros AINE, incluindo inibidores específicos da COX-2, pois podem aumentar o risco de efeitos adversos (ver secção 4.3).

Foram detetadas as seguintes interações de ibuprofeno com outros medicamentos:

- Agentes antiagregantes plaquetários e inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRS) - aumento do risco de hemorragia gastrointestinal (ver secção 4.4).
- Anticoagulantes, incluindo a varfarina — o ibuprofeno interfere com a estabilidade da INR e pode aumentar o risco de hemorragia grave e por vezes fatal, especialmente do trato gastrointestinal. O ibuprofeno só deve ser usado em doentes que tomam varfarina se for absolutamente necessário, tendo estes de ser monitorizados atentamente.
- O ibuprofeno pode diminuir a depuração renal e aumentar a concentração plasmática de lítio.
- O ibuprofeno pode reduzir o efeito anti-hipertensor de inibidores da ECA, betabloqueadores e diuréticos, podendo provocar natriurese e hipercaliemia em doentes a receber estes tratamentos
- O ibuprofeno reduz a depuração de metotrexato.
- O ibuprofeno não deve ser utilizado até 8 a 12 dias após a administração da mifepristona, pois pode reduzir o efeito da mifepristona.
- O ibuprofeno pode aumentar os níveis plasmáticos de glicosídeos cardíacos.
- O ibuprofeno pode aumentar o risco de hemorragia gastrointestinal, especialmente se tomado com corticosteroides.
- O ibuprofeno pode prolongar o tempo de sangramento em doentes tratados com zidovudina.
- O ibuprofeno pode também interferir com probenecida, medicamentos antidiabéticos e fenitoína.
- O ibuprofeno pode também interferir com tacrolímus, ciclosporina, sulfonilureias, antibióticos pertencentes à família das quinolonas e inibidores da CYP2C9 (voriconazol, fluconazol).

BIPARFEN pode interferir com alguns medicamentos, incluindo:

- varfarina, um medicamento usado para prevenir coágulos sanguíneos
- medicamentos para tratar epilepsia ou convulsões
- cloranfenicol, um antibiótico usado para tratar infeções dos ouvidos e oculares
- probenecida, um medicamento usado para tratar a gota
- zidovudina, um medicamento usado no tratamento do VIH (o vírus que causa SIDA)
- medicamentos usados para tratar a tuberculose, como a isoniazida
- ácido salicílico, salicilatos ou outros medicamentos AINE
- medicamentos para tratar a pressão arterial elevada ou outras condições cardíacas
- diuréticos, também chamados de «drenantes»

- lítio, um medicamento usado para tratar alguns tipos de depressão
- metotrexato, um medicamento usado para tratar artrite e alguns tipos de cancro
- corticosteroides, como a prednisona ou a cortisona.

Os medicamentos supramencionados podem ser afetados pelo BIPARFEN ou podem afetar o correto funcionamento do BIPARFEN.

4.6 Fertilidade, gravidez e aleitamento

Gravidez

Não há experiência de uso deste medicamento em mulheres grávidas.

A inibição da síntese de prostaglandinas pode prejudicar a gravidez e/ou o desenvolvimento embrionário/fetal. Dados obtidos de estudos epidemiológicos sugerem um aumento do risco de aborto e de malformação cardíaca após o uso de um inibidor da síntese de prostaglandinas no início da gravidez. O risco absoluto de malformações cardiovasculares aumentou de menos de 1% para aproximadamente 1,5%.

Considera-se que o risco aumenta com a dose e a duração da terapêutica. Em animais, demonstrou-se que a administração de um inibidor da síntese de prostaglandinas resulta num aumento na perda pré e pós-implantação e na mortalidade embrio-fetal. Adicionalmente, reportou-se um aumento da incidência de várias malformações, incluindo cardiovasculares, em animais nos quais foi administrado um inibidor da síntese de prostaglandinas durante o período organogenético. O ibuprofeno não deve ser administrado durante o primeiro e o segundo trimestre de gravidez, a menos que expressamente necessário. Se o ibuprofeno for usado por uma mulher que esteja a tentar engravidar, ou durante o primeiro e o segundo trimestre de gravidez, a dose e a duração do tratamento devem ser as mínimas possíveis.

Durante o terceiro trimestre de gravidez, todos os inibidores da síntese de prostaglandinas podem expor o feto a:

- toxicidade cardiopulmonar (com encerramento prematuro do canal arterial e hipertensão pulmonar);
- disfunção renal, que pode progredir para insuficiência renal com oligoidrâmnio; a mãe e o recém-nascido, no final da gravidez, a:
- possível prolongamento do tempo de hemorragia, um efeito antiagregante que pode ocorrer mesmo em doses muito baixas;
- inibição das contrações uterinas, resultando no atraso ou prolongamento do trabalho de parto.

Uma quantidade elevada de dados em mulheres grávidas a usar paracetamol, indica ausência de malformações ou toxicidade fetal/neonatal. O paracetamol pode ser usado durante a gravidez se houver necessidade clínica; contudo, deve ser usada a dose mais baixa eficaz durante o período de tempo mais curto possível e com a frequência mais baixa possível.

Consequentemente, BIPARFEN não deve ser utilizado durante os primeiros 6 meses de gravidez, a menos que os benefícios potenciais para o doente superem os possíveis riscos para o feto, e é contraindicado nos últimos 3 meses de gravidez (ver seção 4.3).

Amamentação

O paracetamol é excretado no leite materno, mas em doses que não têm expressão clínica e os dados publicados disponíveis não contraindicam a amamentação.

O ibuprofeno e os seus metabolitos podem passar para o leite materno em quantidades muito baixas. Não se conhecem efeitos prejudiciais nos lactentes.

Tendo em conta as evidências supracitadas, não é necessário interromper a amamentação para um tratamento de curta duração com as doses recomendadas deste medicamento.

Fertilidade

O uso do medicamento pode comprometer a fertilidade feminina, não sendo recomendado em mulheres que estejam a tentar engravidar. Deve ser considerada a descontinuação do tratamento em mulheres com dificuldades para engravidar ou que estão a ser submetidas a investigação da infertilidade.

4.7 Efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas

Efeitos indesejáveis como tonturas, sonolência, fadiga e distúrbios visuais, são possíveis após o uso de AINE. Se afetados, os doentes não devem conduzir ou utilizar máquinas.

4.8 Efeitos indesejáveis

Os ensaios clínicos com esta associação não indicaram quaisquer outros efeitos indesejáveis além dos referentes ao paracetamol ou ao ibuprofeno em monoterapia.

As reações adversas foram classificadas de acordo com a sua frequência usando a seguinte convenção:

1. Muito frequentes ($\geq 1/10$);
2. Frequentes ($\geq 1/100$, $< 1/10$);
3. Pouco frequentes ($\geq 1/1.000$, $< 1/100$);
4. Raras ($\geq 1/10.000$, $< 1/1.000$);
5. Muito raras ($< 1/10.000$);
6. Desconhecido (não pode ser calculado a partir dos dados disponíveis).

Infeções e infestações	<u>Muito raras</u> : Foram descritas exacerbações de inflamações relacionadas com infeções (p. ex. desenvolvimento de fascíte necrosante) coincidentes com o uso de AINE.
Doenças do sangue e do sistema linfático	<u>Pouco frequentes</u> : Redução na hemoglobina e no hematócrito. Apesar de não ter sido estabelecida uma relação causal, foram reportados episódios hemorrágicos (p. ex. epistaxe, menorrágia) durante a terapêutica com o medicamento. <u>Muito raras</u> : Foram reportadas alterações hematopoiéticas (agranulocitose, anemia, anemia aplástica, anemia hemolítica, leucopenia, neutropenia, pancitopenia e trombocitopenia com ou sem púrpura) após o uso de ibuprofeno, mas cuja causa não esteve necessariamente relacionada com o medicamento.
Doenças do sistema imunitário	<u>Muito raras</u> : Foram reportadas reações de hipersensibilidade incluindo erupções cutâneas e sensibilidade cruzada com simpaticomiméticos. <u>Pouco frequentes</u> : Foram reportadas outras reações alérgicas, mas não foi estabelecida uma relação causal: Doença do soro, síndrome de lúpus eritematoso, vasculite de Henoch-Schönlein, angioedema.
Doenças do metabolismo e da nutrição	<u>Muito raras</u> : No caso da acidose metabólica, a causalidade é incerta, uma vez que foi ingerido mais do que um fármaco. O caso de acidose metabólica seguiu-se à ingestão de 75 gramas de paracetamol, 1,95 gramas de ácido acetilsalicílico e uma pequena quantidade de um produto de limpeza doméstica líquido. O doente também tinha história de convulsões, pelo que os autores reportaram que estas podem ter contribuído para um aumento dos níveis de lactato indicativos de acidose metabólica. Os efeitos secundários metabólicos incluíram hipocaliemia. Os efeitos secundários metabólicos, incluindo acidose metabólica, foram reportados

	após uma sobredosagem massiva de acetaminofeno. <u>Pouco frequentes:</u> Ginecomastia, reação hipoglicêmica.
Doenças do sistema nervoso	<u>Frequentes:</u> Tonturas, dor de cabeça, nervosismo <u>Pouco frequentes:</u> Depressão, insônia, confusão, instabilidade emocional, sonolência, meningite asséptica com febre e coma <u>Raras:</u> Parestesias, alucinações, sonhos anormais <u>Muito raras:</u> Estimulação paradoxal, neurite ótica, comprometimento psicomotor, efeitos extrapiramidais, tremores e convulsões.
Afeções oculares	<u>Pouco frequentes:</u> Ocorreu ambliopia (visão turva e/ou diminuída, escotomas e/ou alterações na visão das cores), mas usualmente reversível após interrupção da terapêutica. Qualquer doente com queixas oculares deve realizar um exame oftalmológico que inclua os campos centrais da visão.
Afeções do ouvido e do labirinto	<u>Muito raras:</u> Vertigens. <u>Frequentes:</u> Acúfenos (para medicamentos com ibuprofeno)
Cardiopatias	<u>Frequentes:</u> Edema, retenção de fluidos; a retenção de fluidos geralmente responde rapidamente à descontinuação do fármaco. <u>Muito raras:</u> Foram reportados casos de palpitações, taquicardia, arritmias e outras disritmias cardíacas. Foram reportados casos de hipertensão e de insuficiência cardíaca associados ao tratamento com AINE.
Doenças respiratórias, torácicas e do mediastino	<u>Pouco frequentes:</u> Secreções das vias respiratórias espessas. <u>Muito raras:</u> Reatividade respiratória incluindo: asma, exacerbação da asma, broncospasmo e dispneia.
Doenças gastrointestinais	<u>Frequentes:</u> Dor abdominal, diarreia, dispepsia, náuseas, desconforto gástrico e vômitos, flatulência, obstipação, pequenas hemorragias gastrointestinais que, em casos excepcionais, podem provocar anemia. <u>Pouco frequentes:</u> Úlcera péptica/gastrointestinal, perfuração ou hemorragia gastrointestinal, com sintomas de melena e hematêmese por vezes fatais, particularmente nos idosos. Foram reportados, após a administração, casos de estomatite ulcerosa e exacerbação de colites e de doença de Crohn. Com menor frequência, foram detetadas gastrites e reportadas pancreatites. <u>Muito raras:</u> Esofagite, formação de estenoses diafragmáticas intestinais.
Afeções hepatobiliares	<u>Muito raras:</u> Danos hepáticos, especialmente durante tratamento a longo prazo, insuficiência hepática. Função hepática anormal, hepatite e icterícia. A sobredosagem de paracetamol pode provocar insuficiência hepática aguda, insuficiência hepática, necrose hepática e lesões no fígado.
Afeções dos tecidos cutâneos e subcutâneos	<u>Frequentes:</u> Erupções cutâneas (incluindo do tipo maculopapular), prurido. <u>Muito raras:</u> Alopecia. Hiperidrose, púrpura e fotossensibilidade. Dermatites esfoliativas. Reações bolhosas incluindo eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tóxica. Foram reportados casos muito raros de reações cutâneas graves. Em casos excepcionais, podem ocorrer durante a infeção com varicela infeções cutâneas graves e complicações dos tecidos moles. <u>Desconhecido:</u> Reação ao fármaco com eosinofilia e sintomas sistémicos (síndrome de DRESS).
Doenças renais e urinárias	<u>Pouco frequentes:</u> Retenção urinária. <u>Raras:</u> Danos no tecido renal (necrose papilar), particularmente na terapêutica a longo prazo. <u>Muito raras:</u> Nefrotoxicidade de vários tipos, incluindo nefrite intersticial, síndrome nefrótica e insuficiência renal aguda e crónica. Os efeitos adversos renais são mais frequentemente observados após sobredosagem, após abuso crónico (muitas vezes com múltiplos analgésicos) ou associados a hepatotoxicidade relacionada com o paracetamol. Geralmente ocorre necrose tubular aguda juntamente com a insuficiência hepática; contudo, em casos raros observou-se como uma ocorrência isolada. Também foi associado ao uso crónico de paracetamol um possível aumento no risco de carcinoma das células renais.

	Um estudo de casos-controlo de doentes com doença renal terminal sugeriu que o consumo de paracetamol a longo prazo pode aumentar significativamente o risco de doença renal terminal, particularmente em doentes que tomam mais do que 1000 mg por dia.
Perturbações gerais e alterações no local de administração	<u>Muito raras</u> : Fadiga e indisposição
Exames complementares de diagnóstico	<u>Frequentes</u> : Aumento da alanina aminotransferase, aumento da gamaglutamiltransferase e testes da função hepática anormais com paracetamol. Aumento da creatinina sanguínea e aumento da ureia sanguínea. <u>Pouco frequentes</u> : Aumento da aspartato aminotransferase, aumento da fosfatase alcalina sanguínea, aumento da creatina fosfoquinase sanguínea, diminuição da hemoglobina e aumento da contagem de plaquetas. <u>Raros</u> : Concentrações elevadas de ácido úrico no sangue.

Estudos clínicos sugerem que o uso de ibuprofeno, particularmente a uma dose elevada (2400 mg/dia), poderá estar associado a um pequeno aumento do risco de acontecimentos trombóticos arteriais (por exemplo, enfarte do miocárdio ou AVC) (ver secção 4.4).

Notificação de suspeitas de reações adversas

A notificação de suspeitas de reações adversas após a autorização do medicamento é importante, uma vez que permite uma monitorização contínua da relação benefício-risco do medicamento. Pede-se aos profissionais de saúde que notifiquem quaisquer suspeitas de reações adversas através **do sistema nacional de notificação mencionado no [Apêndice V](#)***.

4.9 Sobredosagem

Sintomas

Paracetamol

Após sobredosagem com paracetamol, podem ocorrer lesões hepáticas e até mesmo insuficiência hepática. Os sintomas da sobredosagem com paracetamol nas primeiras 24 horas são palidez, náuseas, vômitos, anorexia e dor abdominal. Os danos hepáticos podem tornar-se aparentes 12 a 48 horas após a ingestão. Podem ocorrer alterações no metabolismo da glucose e acidose metabólica. Em caso de envenenamento grave, a insuficiência hepática pode progredir para encefalopatia, coma e morte. Pode-se desenvolver insuficiência renal aguda com necrose tubular aguda na ausência de danos hepáticos graves. Foram reportadas arritmias cardíacas. É possível ocorrerem danos hepáticos em adultos que tenham tomado 10 g ou mais de paracetamol, devido às quantidades excessivas de um metabolito tóxico.

Ibuprofeno

Os sintomas incluem náuseas, dor abdominal e vômitos, tonturas, convulsões e, raramente, perda de consciência. Os aspetos clínicos que podem resultar da sobredosagem com ibuprofeno são depressão do sistema nervoso central e do sistema respiratório.

Em casos graves de envenenamento, pode ocorrer acidose metabólica.

Tratamento

Paracetamol

O tratamento imediato é essencial na gestão da sobredosagem com paracetamol, mesmo quando não existem sintomas óbvios, devido aos riscos de lesões hepáticas, que aparecem algumas horas ou até mesmo dias mais tarde. Aconselha-se tratamento médico imediato em qualquer doente que tenha ingerido 7,5 g ou mais de paracetamol nas últimas 4 horas.

Deve-se considerar uma lavagem gástrica. Devem ser instituídas, o mais rapidamente possível, terapêuticas específicas para reverter as lesões hepáticas com um antídoto como a acetilcisteína (intravenosa) ou a metionina (oral).

A acetilcisteína é mais eficaz quando administrada durante as primeiras 8 horas após a ingestão da sobredosagem e o seu efeito diminui progressivamente entre as 8 e as 16 horas. Acreditava-se que começar o tratamento mais de 15 horas após a sobredosagem não trazia benefício e poderia possivelmente agravar o risco de encefalopatia hepática.

No entanto, demonstrou-se recentemente que a administração tardia é segura, havendo estudos em doentes tratados até 36 horas após a ingestão que sugerem que é possível obter resultados benéficos para além das 15 horas. Além disso, demonstrou-se que a administração de acetilcisteína intravenosa a doentes que já desenvolveram insuficiência hepática fulminante reduz a morbidade e a mortalidade.

É administrada por via intravenosa uma dose inicial de 150 mg/kg de acetilcisteína em 200 ml de glucose a 5% durante 15 minutos, seguido de uma perfusão IV de 50 mg/kg em 500 ml de glucose a 5% durante 4 horas e, finalmente, 100 mg/kg em 1 litro de glucose a 5% durante 16 horas. O volume dos fluidos IV deve ser modificado para crianças.

A metionina é administrada por via oral, com doses de 2,5 g a cada 4 horas até 10 g. O tratamento com metionina tem de ser iniciado nas primeiras 10 horas após a ingestão do paracetamol; caso contrário, será ineficaz e pode exacerbar os danos hepáticos.

As evidências de sintomas graves poderão não se manifestar nos 4 ou 5 dias seguintes à sobredosagem e os doentes devem ser observados atentamente durante um período prolongado.

Ibuprofeno

O tratamento deve ser sintomático, de suporte e incluir a manutenção de vias respiratórias desimpedidas e a monitorização dos sinais cardíacos e vitais até à estabilização. A lavagem gástrica só é recomendada nos 60 minutos seguintes à ingestão da dose potencialmente fatal. Uma vez que este fármaco é ácido e excretado na urina, é teoricamente benéfico administrar substâncias alcalinas e induzir a diurese. Além das medidas de suporte, o uso de carvão ativado por via oral pode ajudar a reduzir a absorção e a reabsorção dos comprimidos de ibuprofeno.

5. PROPRIEDADES FARMACOLÓGICAS

5.1 Propriedades farmacodinâmicas

Grupo farmacoterapêutico: 2.10 Sistema Nervoso Central. Analgésicos e antipiréticos; Código ATC: N02BE51 – Sistema nervoso. Analgésicos. Outros analgésicos e antipiréticos. Anilidas. Paracetamol, combinações excluindo psicolépticos.

Mecanismo de ação

As ações farmacológicas do ibuprofeno e do paracetamol diferem no local e modo de ação. Estes modos de ação complementares são sinérgicos, resultando num maior efeito analgésico e antipirético comparativamente com o ibuprofeno ou o paracetamol em monoterapia.

Embora o local e o mecanismo exatos da ação analgésica do paracetamol não estejam claramente definidos, parece que induz analgesia através do aumento do limiar de dor. O potencial mecanismo poderá envolver a inibição da via de sinalização do óxido nítrico mediada por uma variedade de recetores de neurotransmissores, incluindo o N-metil-D-aspartato e a substância P.

O ibuprofeno é um derivado do ácido propiónico com atividade analgésica, anti-inflamatória e antipirética. Como um AINE, os efeitos terapêuticos do fármaco resultam do seu efeito inibitório sobre a enzima ciclo-oxigenase, levando a uma redução na síntese de prostaglandinas.

Dados experimentais sugerem que o ibuprofeno pode inibir competitivamente o efeito de doses baixas de ácido acetilsalicílico sobre a agregação plaquetária quando administrados de modo concomitante. Alguns estudos farmacodinâmicos demonstraram que quando foram tomadas doses individuais de ibuprofeno 400 mg nas 8 horas anteriores ou nos 30 minutos posteriores à administração de ácido acetilsalicílico de liberação imediata (81 mg), ocorreu uma diminuição do efeito do ácido acetilsalicílico na formação de tromboxano ou na agregação plaquetária. Apesar de haver incertezas no que se refere à extrapolação destes dados para a situação clínica, não pode ser excluída a possibilidade de que o uso regular e a longo prazo de ibuprofeno pode reduzir o efeito cardioprotetor de baixas doses de ácido acetilsalicílico. Não se considera provável nenhum efeito clinicamente relevante decorrente do uso ocasional de ibuprofeno (ver secção 4.5).

5.2 Propriedades farmacocinéticas

Absorção

Tanto o paracetamol como o ibuprofeno são rapidamente absorvidos a partir do trato gastrointestinal, com a concentração plasmática máxima a ocorrer cerca de 10 a 60 minutos após a administração oral. A taxa e a absorção tanto do paracetamol como do ibuprofeno a partir do medicamento combinado são ligeiramente atrasadas quando a administração ocorre após a ingestão de alimentos.

Distribuição

Tal como com qualquer medicamento que contém paracetamol, este é distribuído para a maioria dos tecidos corporais.

O ibuprofeno encontra-se extensivamente ligado (90–99%) a proteínas plasmáticas.

Biotransformação

O paracetamol é metabolizado extensivamente no fígado e excretado na urina, principalmente na forma de glucoronídeo inativo e conjugados sulfatados. Menos de 5% é excretado na forma não alterada. Os metabolitos do paracetamol incluem um intermediário hidroxilado minoritário que tem atividade hepatotóxica. Este intermediário ativo é detoxificado mediante conjugação com glutatona; no entanto, pode acumular após sobredosagem com paracetamol e, se não tratado, tem potencial para causar danos hepáticos graves e até mesmo irreversíveis.

O paracetamol é metabolizado de modo diferente por crianças prematuras, recém-nascidos e crianças jovens comparativamente com os adultos, sendo o conjugado sulfatado a forma predominante.

O ibuprofeno é extensivamente metabolizado em compostos inativos no fígado, principalmente por glucoronidação.

As vias metabólicas do paracetamol e do ibuprofeno são distintas e não deve haver nenhuma interação medicamentosa na qual o metabolismo de um afeta o metabolismo do outro. Um estudo formal usando enzimas hepáticas humanas para investigar tal possibilidade não encontrou nenhuma interação medicamentosa potencial ao nível das vias metabólicas.

Eliminação

O tempo de semivida de eliminação do paracetamol varia entre 1 e 3 horas.

Tanto os metabolitos inativos como uma pequena quantidade de ibuprofeno não alterado são excretados rápida e completamente pelos rins, com 95% da dose administrada eliminada na urina no período de quatro horas após a ingestão. A semivida de eliminação do ibuprofeno é de cerca de 2 horas.

Relação farmacocinética

Um estudo específico para investigar possíveis efeitos do paracetamol na depuração plasmática do ibuprofeno e vice-versa não identificou qualquer interação medicamentosa.

5.3 Dados de segurança pré-clínica

Os perfis de segurança toxicológica do ibuprofeno e do paracetamol foram estabelecidos em experiências com animais. Não existem novos dados pré-clínicos relevantes, para além dos já apresentados neste Resumo das Características do Medicamento.

6. INFORMAÇÕES FARMACÊUTICAS

6.1. Lista dos excipientes

Glicerol
Benzoato de sódio
Citrato de sódio
Ácido cítrico anidro
Cloreto de sódio
Polissorbato 80
Goma xantana
Silicato de magnésio sódico tipo IA
Isomalte
Sucralose
Aroma de laranja
Água purificada

6.2 Incompatibilidades

Não aplicável.

6.3 Prazo de validade

2 anos

6.4 Precauções especiais de conservação

Não conservar acima de 25° C.

6.5 Natureza e conteúdo do recipiente

BIPARFEN apresenta-se num frasco de vidro âmbar, tipo III de 100 ml de capacidade, com um dispositivo de medida.

6.6 Precauções especiais de eliminação e manuseamento

Não existem requisitos especiais.

Qualquer medicamento não utilizado ou resíduos devem ser eliminados de acordo com as exigências locais.

7. RESPONSÁVEL PELA COLOCAÇÃO NO MERCADO

BIAL - Portela & C^a, S.A.
À Av. da Siderurgia Nacional
4745-457 S. Mamede do Coronado · Portugal
E-mail: info@bial.com

8. DATA DA REVISÃO DO TEXTO

Novembro de 2020